

虐待・児童福祉

令和 8年 3月25日
名古屋市西部地域療育センター
宮地 泰士

<児童虐待とは(児童虐待防止法による定義)>

・保護者が、その監護する児童について次に掲げる行為。

1 身体的虐待

- ・殴る、蹴る
- ・物を投げつける
- ・閉め出す
- ・揺さぶられっ子症候群
- ・火傷を負わせる
- ・閉じ込める

2 ネグレクト (育児放棄)

- ・十分な食事を与えない
- ・不衛生な状態のままにさせる
- ・長時間子どもだけで放置する
- ・学校や病院に行かせない
- ・他者の虐待を放置する

3 性的虐待

- ・性的行為をせまら、見せる
- ・性的いたづら、性器を見せる
- ・ポルノグラフィを見せる、被写体にする

4 心理的虐待

- ・言葉の暴力(人格を否定する言葉)、脅し
- ・子どもに対して無視や拒否的態度
- ・差別的扱いや差別の言動
- ・暴力的行為(DVなど)を見せる

※その他のものとして、代理ミュンヒハウゼン症候群がある。

※児童：0歳から18歳までの者。

保護者：親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者。

虐待とは、“子どもが安全ではない状態”

坂井聖二

<揺さぶられっ子症候群(SBS)>

Shaken Baby Syndrome, Shaking impact (baby) syndrome

* 乳幼児を暴力的に揺さぶることによって起こり、下記の症状を呈する状態。

- ・ 頭蓋内出血(多くは多発性出血)
- ・ 白質裂傷(前頭葉や側頭葉に多い)
- ・ びまん性軸索損傷(軸索の浮腫とびまん性出血)
- ・ 脳浮腫
- ・ 眼底出血(網膜出血)
- ・ 頸髄損傷(特に上位頸髄損傷)
- ・ 肋骨や脊柱の損傷などの全身性の傷害

※ しかし近年、これまでSBSの典型的症状とされた、急性硬膜下血腫、眼底出血、脳浮腫が乳児揺さぶり以外でも生じうるとして、SBSの立証根拠にはならず無罪判決となる事例が相次ぐようになってきた。

- * 致死性または重度の後遺症を残す予後不良な疾患。
- * 被害児は、大半が1歳未満、中でも6カ月未満が多い。
(赤ちゃんの泣き声が原因であることが多い)
- * 明らかな外傷が見られないことが多いため、“突然死”と見誤られる可能性がある。

<代理ミュンヒハウゼン症候群>

Munchausen syndrome by proxy

※ミュンヒハウゼン症候群: 病的虚言症

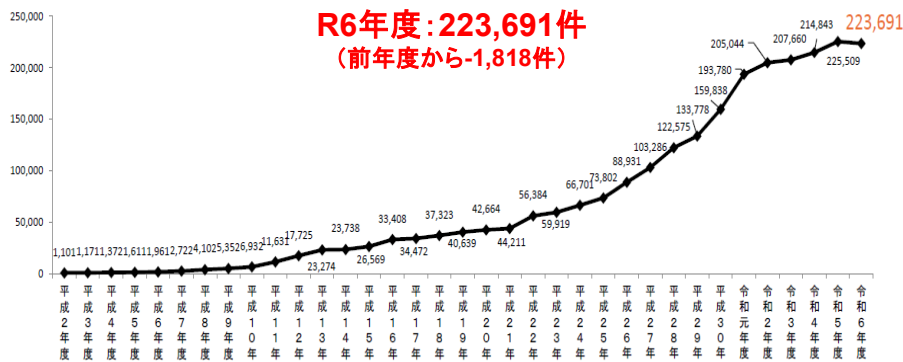
* 子どもに病気をねつ造したり傷つけるなどして、自らの精神的満足を得たり恩恵を得ようとする状態。

例えば、自分が一生懸命に子どもの世話や看護をしている姿を周囲に見せることで、自分に対する関心を引き寄せるなど。

- * 加害者は実母が多い。
- * 医学的知識が豊富であったり、医療者に対し攻撃的あるいは非協力的な態度を示すこともある。
- * 巧妙な場合、発見は容易ではない。
- * 以下のような特徴を認めることがある。

- ・ 訴えの内容が子どもの状態と合わない。
- ・ 病院を転々と渡り歩く既往がある。
- ・ 不自然な臨床経過をたどる。
- ・ 親が用心深く患児から離れない。
- ・ 治療を妨害する人為的な事象が起こる。
- ・ 親の言動に不審な点がみられる。
- ・ 症状の訴えに客観的な根拠が乏しい。

<全国の児童相談所における児童虐待相談対応件数>



(注) 平成22年度の件数は、東日本大震災の影響により、福島県を除いて集計した数値。

平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
73,802	88,931	103,286	122,575	133,778	159,838	193,780	205,044	207,660	214,843	225,509	223,691
+10.6%	+20.5%	+16.1%	+18.7%	+9.1%	+19.5%	+21.2%	+5.8%	+1.3%	+3.5%	+5.0%	-0.8%

相談経路: 警察51.7%、近隣・知人8.9%、家族・親戚8.4%、学校8.0%

子ども家庭庁Hpより

<全国の児童相談所における児童虐待相談の虐待種別の割合>

	身体的虐待		ネグレクト		性的虐待		心理的虐待		総数	
平成25年度	24,245	(32.9%)	19,627	(26.6%)	1,582	(2.1%)	28,348	(38.4%)	73,802	(100.0%)
平成26年度	26,181	(29.4%)	22,455	(25.2%)	1,520	(1.7%)	38,775	(43.6%)	88,931	(100.0%)
平成27年度	28,621	(27.7%)	24,444	(23.7%)	1,521	(1.5%)	48,700	(47.2%)	103,286	(100.0%)
平成28年度	31,925	(26.0%)	25,842	(21.1%)	1,622	(1.3%)	63,186	(51.5%)	122,575	(100.0%)
平成29年度	33,223	(24.8%)	26,821	(20.0%)	1,537	(1.1%)	72,197	(54.0%)	133,778	(100.0%)
平成30年度	40,238	(25.2%)	29,479	(18.4%)	1,730	(1.1%)	88,391	(55.3%)	159,838	(100.0%)
令和元年度	49,240	(25.4%)	33,345	(17.2%)	2,077	(1.1%)	109,118	(56.3%)	193,780	(100.0%)
令和2年度	50,035	(24.4%)	31,430	(15.3%)	2,245	(1.1%)	121,334	(59.2%)	205,044	(100.0%)
令和3年度	49,241	(23.7%)	31,448	(15.1%)	2,247	(1.1%)	124,724	(60.1%)	207,660	(100.0%)
令和4年度	49,464	(23.0%)	34,872	(16.2%)	2,393	(1.1%)	128,114	(59.6%)	214,843	(100.0%)
令和5年度	51,623	(22.9%)	36,465	(16.2%)	2,473	(1.1%)	134,948	(59.8%)	225,509	(100.0%)
令和6年度	52,535	(23.5%)	35,612	(15.9%)	2,520	(1.1%)	133,024	(59.5%)	223,691	(100.0%)

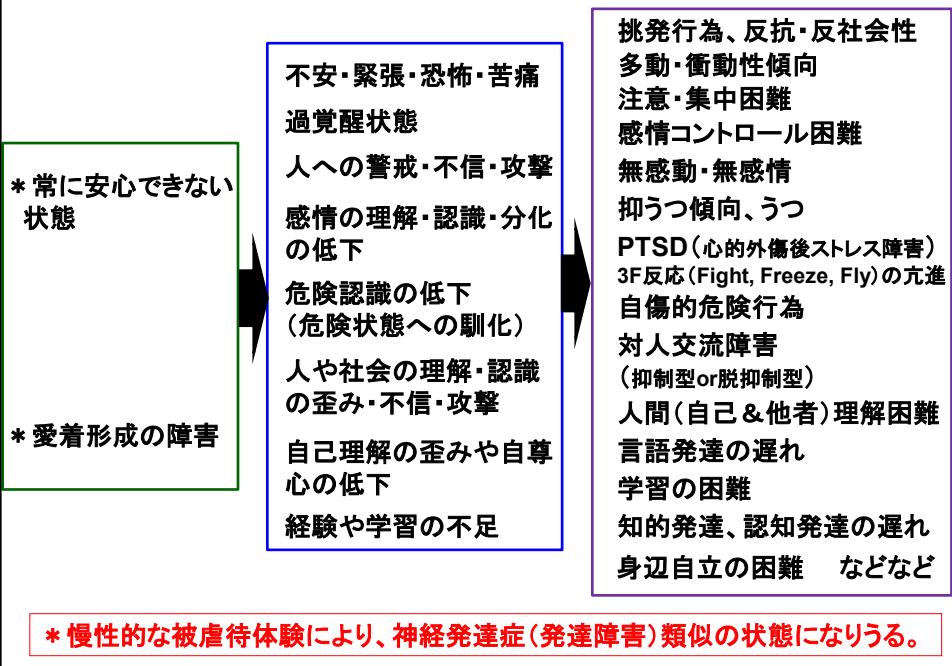
R6年度

心理的虐待: 59.5% 身体的虐待: 23.5% ネグレクト: 15.9% 性的虐待: 1.1%

このうち、58.6%が面談DV

子ども家庭庁Hpより

＜虐待を受けた児の発達・行動・性格特徴の変化＞



＜逆境的児童期体験による人への影響＞

ACE: Adverse Childhood Experiences

* 児童期に慢性的な逆境体験(長期に渡る戦争や被災、被虐待・マルトリートメント、いじめ、により、生涯にわたり生活不適応に陥る感情、認知・思考、行動、身体 の症状・反応が生じる(発達性トラウマ障害)。

〔※マルトリートメント: 家庭内での児童虐待に限らず、子どもの心身を傷つける 関わり(不適切な養育・指導・関わり等)の総称〕

* 被虐待児や愛着障害児では、社会性(対人交流)、注意や感情制御、言語や 知能の遅れを生じることがある(発達障害と類似の症状が生じる)。

* 被虐待児では、受けた虐待の種類によって異なる脳内部位に萎縮や機能低下 が生じる。
友田明美著「子どもの脳を傷つける親たち」NHK出版新書

* 環境からの刺激によって遺伝子の発現(機能発揮)のON/OFFが生じることが ある(エピジェネティクス)。

* トラウマや二次障害に伴う行動・精神・周囲との関係の問題が悪化していくと、 最終的には短命となるリスクが上がる。

* 人は自分が受けた養育・教育・指導を基盤として、次世代(子ども達)を養育・ 教育・指導する傾向がある(世代間連鎖)。

<児童虐待を疑う医学的な所見>

- * 傷や症状と合わない不審な説明
- * 多数の打撲痕や新旧混在した外傷痕
- * 独特の外傷痕
(タバコの火傷痕、二重条痕、縛り痕、咬痕など)
- * 体の内側の外傷痕
- * 乳児の硬膜下血腫(頭蓋内出血)
- * 乳幼児の骨折(特に新旧混在、多発骨折)
- * エスカレート(再発、重症化)してくる怪我
- * 低身長、低体重、成長不良、極端な低栄養状態
- * 不衛生
- * 外陰部の傷

- * 無表情、不安・緊張や警戒感のある表情
- * 大人とのやりとりや触られることへのおびえ
- * 大人(親)の顔色を非常にうかがう様子や過度な反応
- * 親がいる時といない時とでの言動や表情の変化
- * 家に帰りたがらない(帰ることを躊躇する)
- * 保護者の説明が子どもの状態と合わない

<診療で児童虐待を疑ったら>

- * 丁寧に親の説明や子ども自身の説明を聞きとる。
- * それぞれが正直に話しやすいようにする配慮や守秘。
- * 全身の詳細なチェック、図示や写真などによる記録。
- * 入院、治療、精査による一時保護(病院への委託一時保護)。
- * 当事者と外部(自院含む)との関係を拡充・維持させること。
- * むやみに親を追究したり責めたりしない。
- * 医療者としてできるだけ客観的に冷静に判断・対応する。
- * 1人で抱え込まない(相談できる所や人に相談する)。



<児童虐待への対応における連携協力者(機関)>

- * 児童相談所: 児童の処遇(保護など)検討、家庭への介入
(*児童相談所虐待対応ダイヤル: 189*)
- * 院内虐待対応委員会、ソーシャルワーカー
- * 保健師(保健所、保健センター)
- * 市町村(区)の担当窓口
- * 地域(民間)の虐待対策ネットワーク
- * 警察: 事件(死亡例など)への司法的関与
- * 弁護士: 法律的な助言・指導

※児童虐待防止法にて虐待通告は守秘義務違反に問われないとされている。

<児童相談所とは>

・児童福祉法に基づき、児童やその家庭(養育)の援助および児童の安全と権利を擁護するために、都道府県、政令指定都市、中核都市に設置された児童福祉の専門機関。

* 対応する相談内容

- ①養護相談(家庭環境評価、**児童虐待対応**など)
- ②障害相談(児童の療育手帳判定、診断や発達・養育支援など)
- ③非行相談(非行・触法行為や家出・徘徊などへの対応)
- ④育成相談(家庭内暴力、自殺・自傷、不登校、性格・行動問題、養育相談など)
- ⑤その他(里親制度、養子縁組など)

* 基本的機能と民法上の権限

・基本的機能

- ①市町村援助機能(市町村の児童家庭相談への対応や連絡調整、情報提供など)
- ②相談機能(専門的な見地から調査、診断、判定を行い援助、社会資源活用など)
- ③一時保護機能(必要に応じて子どもを家庭から離して一時的に保護する)
- ④措置機能(子どもを児童福祉施設等や里親等に委託、子どもや保護者の指導を児童福祉司、児童委員、市町村、児童家庭支援センター等に行わせる)

・民法上の権限:親権者の親権喪失の審判請求、未成年後見人選任請求など

<児童虐待発見の難しさ>

* 虐待通報の難しさ

- ・子どもの証言の得られにくさ
状況の理解力、言語能力、実行(交渉)力、対処の知識不足、
後ろめたさ(自信のなさ)、将来への不安、親への気遣い、恥
- ・虐待の被疑者(親)との関係不調や判断責任への恐れ
- ・虐待環境の問題
慢性的な慣れ、支配関係の成立、密室性、個人主義の尊重

* 虐待か否かの判別の難しさ “しつけ”であっても体罰や暴言はダメ!

- ・身体的虐待
~~“しつけ”か虐待か?~~ 故意か事故・疾病か? 他害か自傷か?
- ・ネグレクト
疾患(障害)かネグレクトか? 養育に一貫性がない場合
- ・性的虐待
虐待事実の証明(証拠)
- ・心理的虐待
虐待事実の証明(証拠) ~~“しつけ”か虐待か?~~ 当事者間の関係

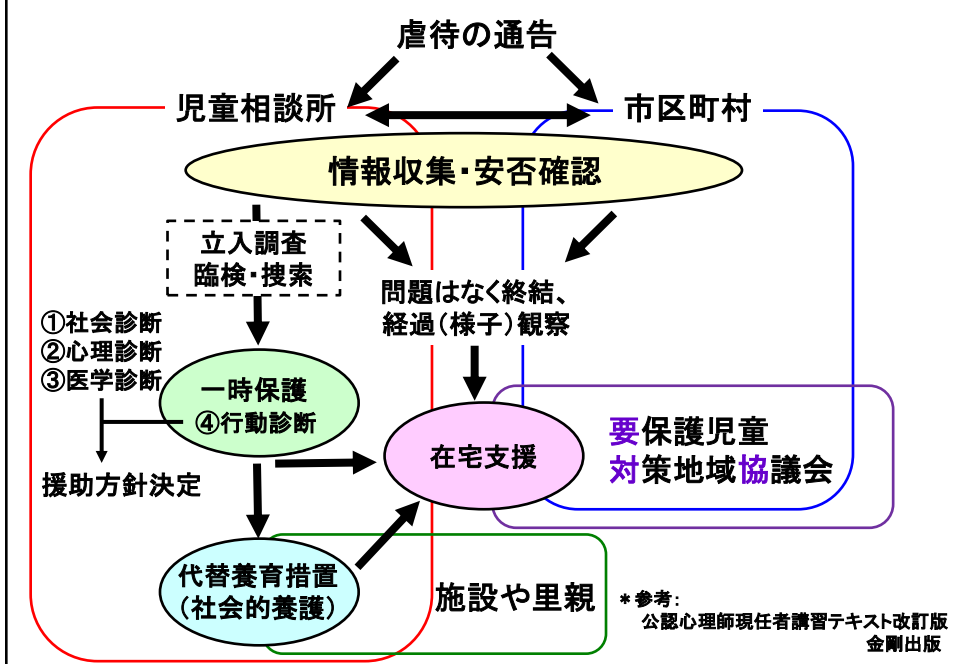
* “疑わしき”は、放置しない(通報、相談、関係継続)。

＜虐待との鑑別が必要な疾病＞

- * 蒙古斑、血管腫、母斑
- * じんましん
- * 水痘、膿痂疹
- * 紫斑病
- * 血友病、凝固異常疾患
- * 骨形成不全症
- * 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- * 神経発達症（発達障害）

などなど

＜児童（子ども）虐待通告後の流れ＞



＜保護(親子分離)した後の支援の課題＞

* 保護(親子分離)されたという経験へのケア

- ・ 子ども自身も自責の念に悩むことがある。
- ・ 分離した親や将来のことを気に病む。

* 保護(親子分離)した後の生活のフォロー

- ・ 保護施設の体制維持や生活環境の未整備。
- ・ 保護所での生活の難しさ(違う場所、違うリズムとルール、より複雑な子同士の集団生活、施設という新たな“密室”等)。
- ・ 保護所職員の専門性の向上が必要。施設内虐待のリスク
- ・ 保護中の親(家族)との関係の調整。

※平成30(2018)年度から児童福祉法では、家庭や家庭と同等の環境(里親、養子縁組、少人数制施設など)における養育支援の促進が示唆されている。

* 親子の再出発の支援

- ・ どのように再出発をさせるのか(お互いの距離、役割など)。
- ・ 再出発をどのようにフォローするのか。

＜児童(子ども)虐待のハイリスク要因＞

* 子ども側の要因

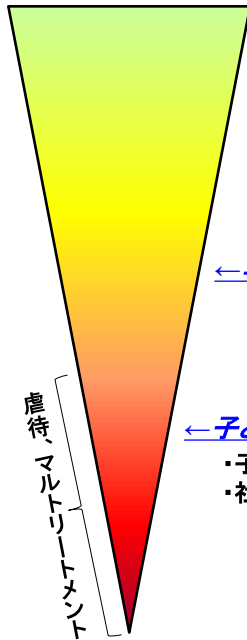
- ・ 発達障害(傾向)を持つ子ども(気になる子、扱いの難しい子ども)
- ・ 過敏な気質の子ども(泣いてばかりいる、疳の虫が強い、HSC)
- ・ 疾病や発育不良を持つ子、低出生体重児
- ・ 多胎児
- ・ 望まない妊娠・出産
- ・ 乳幼児

※HSC: Highly sensitive child (children)

* 保護者(大人)や社会側の要因

- ・ 発達障害や精神疾患、依存症などを持つ保護者
- ・ 経済的負担が大きい(生活困窮)家庭
- ・ ストレス閾値が低い、あるいはストレス解消に困難がある保護者
- ・ 孤立感や自己負担感、育児不安が大きい保護者
- ・ 非定型的家族(若年の親、片親、家族ではない同居人がいる など)
- ・ 自身が虐待を受けて育った保護者(虐待の世代間連鎖)
- ・ 封建的で体罰が容認されやすい文化的環境
- ・ コミュニケーションが乏しく各々が孤立化しやすい家庭や地域社会
- ・ 子どもに対する要求水準が高い保護者
- ・ 子どもや子育てに関する知識不足や誤った知識を持つ保護者

<日本における児童虐待対策>



←発生予防(虐待リスクの軽減)

- ・児童虐待防止意識の啓発
- ・育児環境改善虐待リスク軽減のための様々な施策
- ・適切な(より良い)育児のための支援(育児相談)の充実

※発達障害者支援法では、ペアレント・トレーニングの普及も目指している。

←早期発見・対応、子どもの保護

- ・虐待が深刻化する前に発見し対応するシステムの整備
- ・被虐待児の保護を速やか、かつ、適切に行うための体制作り

←子どもと親の支援、再発防止

- ・子どもと親の両者に対する支援の充実
- ・社会的な養護体制の充実

*** 児童虐待防止対策はR5年4月1日から、厚生労働省から子ども家庭庁へ移管**

<児童虐待防止法の改正>

- ・2004年 「児童虐待は著しい人権侵害である」と明記し、面前DVも虐待とする。児童虐待を受けたと思われる児童を通告する義務。警察等との連携。

- ・2007年 虐待通報を受けた時の児童相談所等の速やかな対応(48時間ルール)。立入調査の強化。

- ・2019年 体罰によるしつけの禁止。児童虐待防止対策の抜本的強化。

※懲戒権(民法822条)「親権者は監護及び教育に必要な範囲で子を懲戒できる」を削除(2022年12月)

- * 2024年6月に「子ども性暴力防止法」が成立し、2026年12月25日に施行された。

児童等に教育・保育等を提供する事業者(学校、保育所、幼稚園、児童福祉施設等)は従業者による児童対象の性暴力等(不同意性交、性的部位への接触、児童買春、児童ポルノ撮影・所持、わいせつな言動、のぞきや盗撮等)を防止する措置を講じることを義務づける。

- ・性暴力防止策の構築と実施
- ・性暴力が発生した場合の適切な対応
- ・従業者等の特定性犯罪前科の有無確認と対処など



＜児童福祉法の理念と日本における最近の児童福祉施策＞

* 児童福祉法

すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、かつ、育成されるよう努めなければならない。

すべての児童は、等しくその生活を保障され愛護されなければならない。

国および地方公共団体は児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

* 要保護児童等への包括的かつ計画的な支援の実施を市町村業務に追加

* 市町村における子育て家庭への支援の充実

- ・子育て世帯訪問支援事業、・児童育成支援拠点事業、
- ・親子関係形成拠点事業、・子育て短期支援事業、・一時預かり事業

* 市町村における子ども家庭センターの設置の努力義務化

(2026年5月現在の設置率:71%)

- ・全ての妊産婦・子育て世帯を対象に、母子保健と児童福祉の一体的支援を行う機関
- ・これまでの子育て世代包括支援センターと、子ども家庭総合支援拠点とを統合
(対象:妊娠期～未就学児の親子) (対象:就学後～18歳未満の子と親)
- ・児童相談所や地域の関係施設等と連携協働して、親子に必要な支援につなぐ拠点